

VALVOPATIA AGUDA — RECONHECER + ESTABILIZAR + CIRURGIA

AS TRÊS VALVOPATIAS AGUDAS CRÍTICAS

Lesão	Causas agudas	Apresentação
Insuficiência mitral aguda	Ruptura de músculo papilar (IAM), endocardite, ruptura de cordoalha	Edema agudo de pulmão súbito, choque, sopro pode ser discreto
Insuficiência aórtica aguda	Endocardite, dissecação de aorta tipo A, trauma	EAP, choque, taquicardia; sopro diastólico curto, pulso pode não ser amplo
Estenose aórtica crítica	Descompensação de EAo grave preexistente	Síncope, angina, IC; sopro sistólico ejetivo em foco aórtico
Trombose de prótese	Anticoagulação inadequada	IC aguda, abafamento das bulhas protéticas, fenômeno embólico
Disfunção de prótese	Deiscência, leak paravalvar, endocardite de prótese	IC aguda, hemólise, sopro novo

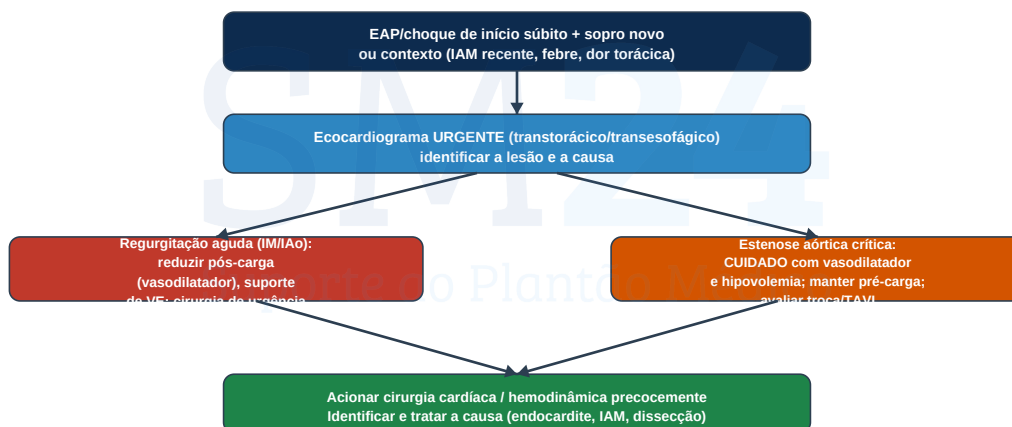
PORQUE A FORMA AGUDA É TÃO GRAVE

SEM TEMPO DE ADAPTAÇÃO = COLAPSO HEMODINÂMICO

- Na regurgitação aguda, o ventrículo e o átrio NÃO tiveram tempo de dilatar/remodelar
- Pequeno volume regurgitante gera pressões muito altas -> edema pulmonar súbito
- O sopro pode ser pouco audível justamente por equalização rápida de pressões (não subestimar)
- Frequentemente cursa com choque cardiogênico de instalação rápida
- Ecocardiograma à beira-leito é decisivo para o diagnóstico
- Tratamento definitivo costuma ser CIRÚRGICO de urgência — estabilizar é ponte, não cura

ABORDAGEM DA SUSPEITA DE VALVOPATIA AGUDA

IC AGUDA + SOPRO NOVO -> PENSAR EM VALVA



PRINCÍPIOS DE ESTABILIZAÇÃO

Lesão	Fazer	Evitar
Insuf. mitral aguda	Reduzir pós-carga (nitroprussiato), diurético, balão intra-aórtico como ponte	Não retardar a cirurgia
Insuf. aórtica aguda	Reduzir pós-carga; inotrópico se choque; cirurgia urgente	Betabloqueador isolado (bloqueia a taquicardia compensatória); balão intra-aórtico (contraindicado)
Estenose aórtica crítica	Manter pré-carga e RVS; cuidado com volume; vasopressor (noradrenalina/fenilefrina) se hipotensão	Vasodilatadores e hipovolemia (queda abrupta do débito)
Trombose de prótese	Anticoagulação plena; fibrinólise ou cirurgia conforme caso	Atraso na avaliação cirúrgica
Endocardite com valvopatia	ATB precoce + hemoculturas; avaliar cirurgia	Manipular sem cobertura antibiótica

PISTAS DIAGNÓSTICAS

Sopros e Achados

- IM aguda: sopro sistólico, pode ser breve/pouco audível; B3, EAP
- IAo aguda: sopro diastólico curto, ausculta de fechamento mitral precoce
- EAo crítica: sopro sistólico ejetivo rude, irradiação para carótidas, pulso parvus et tardus
- Endocardite: febre + sopro novo + fenômenos embólicos/imunológicos
- Ecocardiograma define a gravidade e a causa em todos

Não Esquecer

- IM aguda pós-IAM (ruptura de papilar): 2-7 dias após o infarto, deterioração súbita
- IAo aguda + dor torácica/dorsal: pensar em dissecação de aorta tipo A
- Endocardite: 3 hemoculturas antes do ATB; ecocardiograma transesofágico
- EAo grave: evitar nitrato/vasodilatador na dor torácica sem confirmar a anatomia
- Hemólise + prótese: suspeitar de leak paravalvar

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Suspeitar de valvopatia aguda em todo EAP/choque súbito com sopro novo
- ☐ Ecocardiograma urgente é o exame decisivo
- ☐ Regurgitação aguda: reduzir pós-carga e acionar cirurgia precocemente
- ☐ Estenose aórtica crítica: manter pré-carga/RVS, cuidado com vasodilatadores
- ☐ Tratar a causa: endocardite (ATB), IAM (reperfusão), dissecação (cirurgia)
- ☐ Acionar cirurgia cardíaca/hemodinâmica desde o início — a estabilização é ponte

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente no 4o dia pós-IAM evolui com edema agudo de pulmão súbito, choque e novo sopro sistólico. Qual a principal hipótese?

- A) Reinfarto sem complicação mecânica
- B) Insuficiência mitral aguda por ruptura de músculo papilar
- C) Pericardite pós-infarto
- D) Estenose aórtica crônica descompensada
- E) Embolia pulmonar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que, na regurgitação valvar AGUDA, o sopro pode ser discreto apesar da gravidade do quadro?

- A) Porque a valva ainda está competente
- B) Porque a equalização rápida de pressões entre as câmaras reduz o gradiente e a intensidade do sopro
- C) Porque o débito cardíaco está aumentado
- D) Porque a ausculta é sempre normal nessas situações
- E) Porque o sopro só aparece na forma crônica

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com estenose aórtica crítica e hipotensão. Qual conduta é mais segura?

- A) Nitroprussiato para reduzir a pós-carga
- B) Manter pré-carga e resistência vascular; usar vasopressor (noradrenalina/fenilefrina) se necessário e avaliar troca valvar/TAVI
- C) Diurético agressivo
- D) Betabloqueador em altas doses
- E) Vasodilatador venoso para aliviar a congestão

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com insuficiência aórtica aguda e dor torácica intensa irradiando para o dorso. Qual causa deve ser investigada com urgência?

- A) Pericardite viral
- B) Dissecção de aorta tipo A
- C) Espasmo esofágico
- D) Pneumonia
- E) Costocondrite

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o exame decisivo à beira-leito para o diagnóstico de uma valvopatia aguda no PS?

- A) Radiografia de tórax
- B) Ecocardiograma (transtorácico/transesofágico)
- C) Dosagem de BNP isolada
- D) Eletrocardiograma
- E) Cateterismo direito

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Deterioração súbita com EAP, choque e sopro novo entre 2 e 7 dias pós-IAM sugere complicação mecânica: insuficiência mitral aguda por ruptura/disfunção de músculo papilar. É emergência cirúrgica; estabilizar com redução de pós-carga e suporte (balão intra-aórtico) como ponte.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na regurgitação aguda, não há tempo de remodelamento; as pressões se equalizam rapidamente entre as câmaras, reduzindo o gradiente e tornando o sopro breve e pouco intenso, apesar de grave repercussão hemodinâmica. Não subestimar pela ausculta discreta.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na estenose aórtica crítica, o débito é fixo e dependente de pré-carga e pós-carga. Vasodilatadores e hipovolemia causam queda abrupta do débito e colapso. Conduta: manter pré-carga/RVS, usar vasopressor se hipotenso e avaliar troca valvar cirúrgica ou TAVI.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Insuficiência aórtica aguda com dor torácica/dorsal lancinante deve levantar a suspeita de dissecação de aorta tipo A (que compromete a valva aórtica). É emergência cirúrgica; confirmar com imagem (ECO transesofágico/angio-TC) e acionar cirurgia cardíaca.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O ecocardiograma (transtorácico e, quando necessário, transesofágico) é o exame decisivo à beira-leito: identifica a lesão valvar, a gravidade da regurgitação/estenose e a causa (endocardite, ruptura, dissecação), guiando o tratamento.

SM24
Suporte ao Plantão Médico